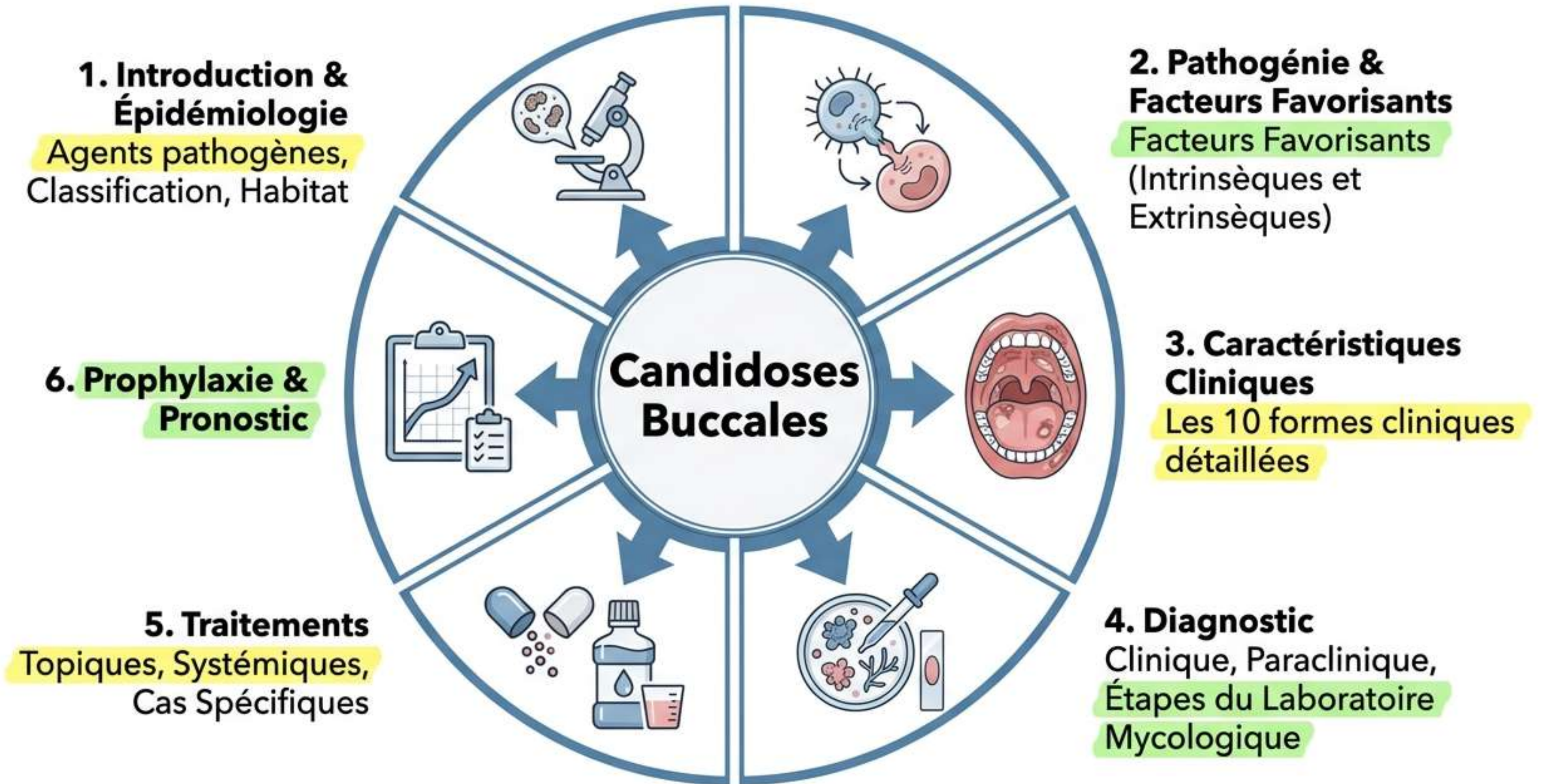


Candidoses Buccales - Guide d'Étude Intégral 2025-2026

Épidémiologie, Pathogénie, Clinique, Diagnostic et Traitements



Exam Pattern Analysis : Stratégie de Maîtrise des QCM

Thèmes les plus répétés (Très Haute Probabilité) :

L'espèce prédominante (**C. albicans**), la forme majeure (**Muguet**), et les traitements de première intention (**Nystatine**).

Nombres et Valeurs :

Fort potentiel sur les posologies thérapeutiques, les seuils d'immunodépression (**CD4, PN**), et la taille cellulaire (**2 à 4µ**).

Zones rarement examinées (Pièges) :

La classification taxonomique exacte, les espèces non-albicans spécifiques, et les étapes précises des prélèvements (tubes de biopsie).

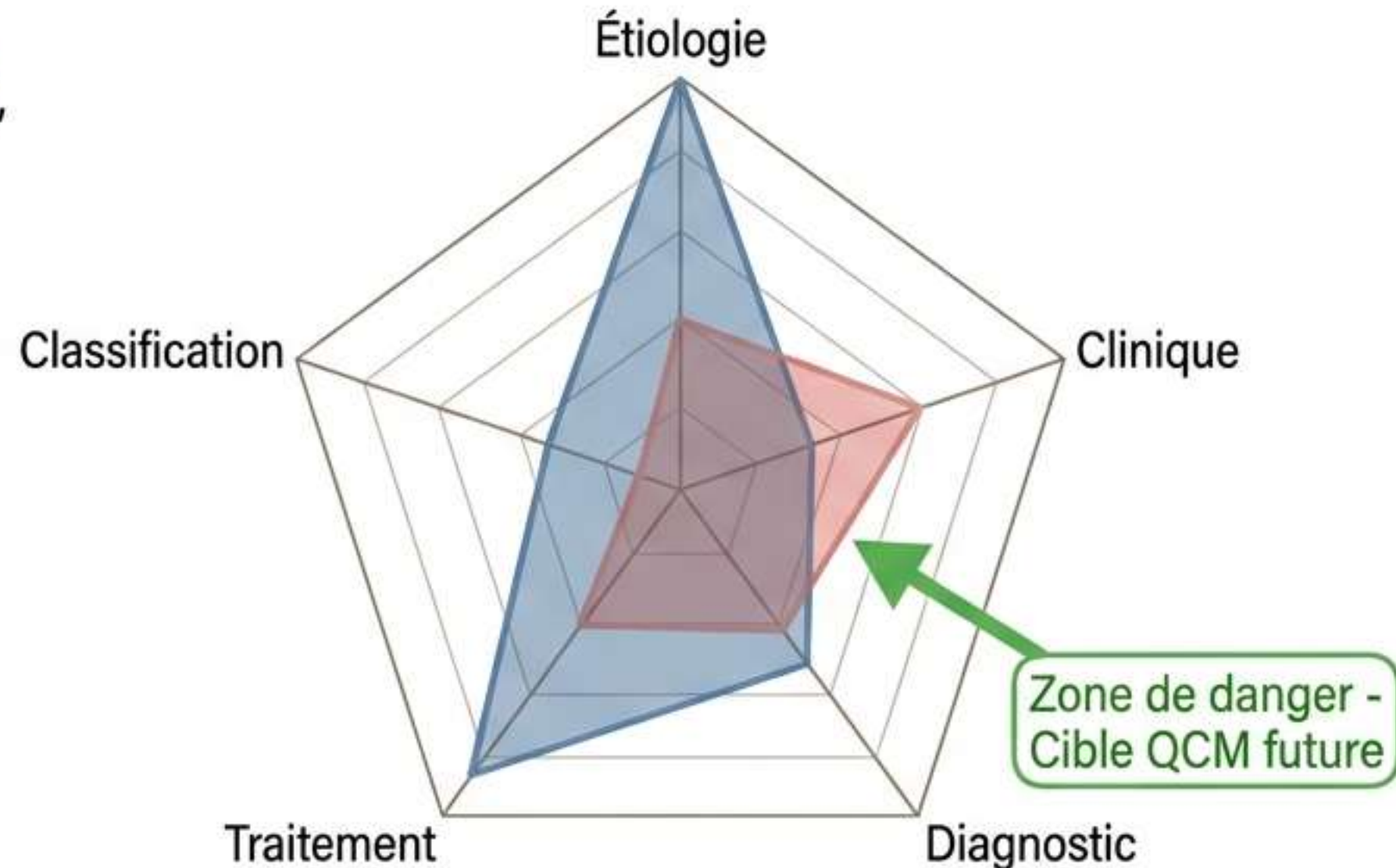
Indice de Confiance de Prédiction :

92% de récurrence sur les bases clinico-thérapeutiques.

Code Couleur Disciplinaire (Règle Suprême) :

Surlignage JAUNE = Sujet validé dans les QCM passés (Maîtrise absolue).

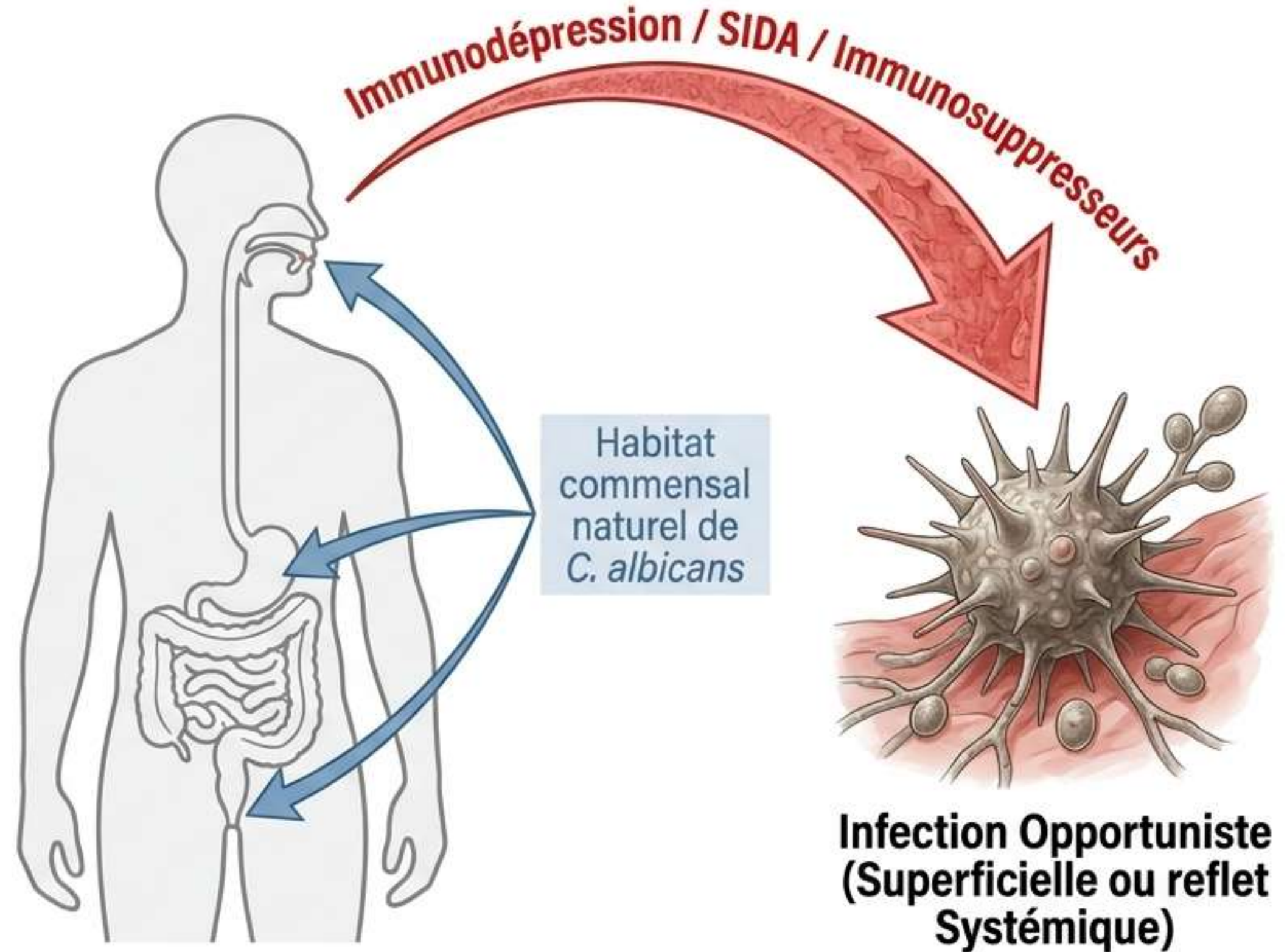
Surlignage VERT = Prédiction forte pour 2025-2026 (Sujets fondateurs non encore testés).



1. Introduction aux Candidoses Buccales

Concepts Clés

- Fréquence mondiale en forte augmentation (liée aux patients immunodéprimés et médicaments immunosuppresseurs).
- Ce sont les mycoses les plus fréquemment diagnostiquées, majoritairement superficielles. Les lésions peuvent être primitives ou le reflet d'une atteinte systémique.
- *Candida albicans* (*C. albicans*) est l'espèce la plus isolée, c'est un commensal naturel des muqueuses buccales, digestives et génitales [Ref: Q1, Q4, Q5].
- **Historique** : Au premier plan lors de l'épidémie de SIDA (infection opportuniste révélatrice).
- **Rôle clé** : L'aspect clinique permet le diagnostic, l'examen mycologique permet l'isolement et l'identification de l'espèce [Predicted - Rôle complémentaire clinique/lab].
- Évolution le plus souvent bénigne, excellente réponse aux antifongiques locaux.



2. Épidémiologie : Agents Pathogènes et Habitat

Mycoses orales dues aux levures du genre *Candida* (plus de 200 espèces au total, dont 23 impliquées en pathologie humaine).

Candida albicans est l'agent pathogène le plus fréquemment mis en cause [Ref: Q1, Q5].

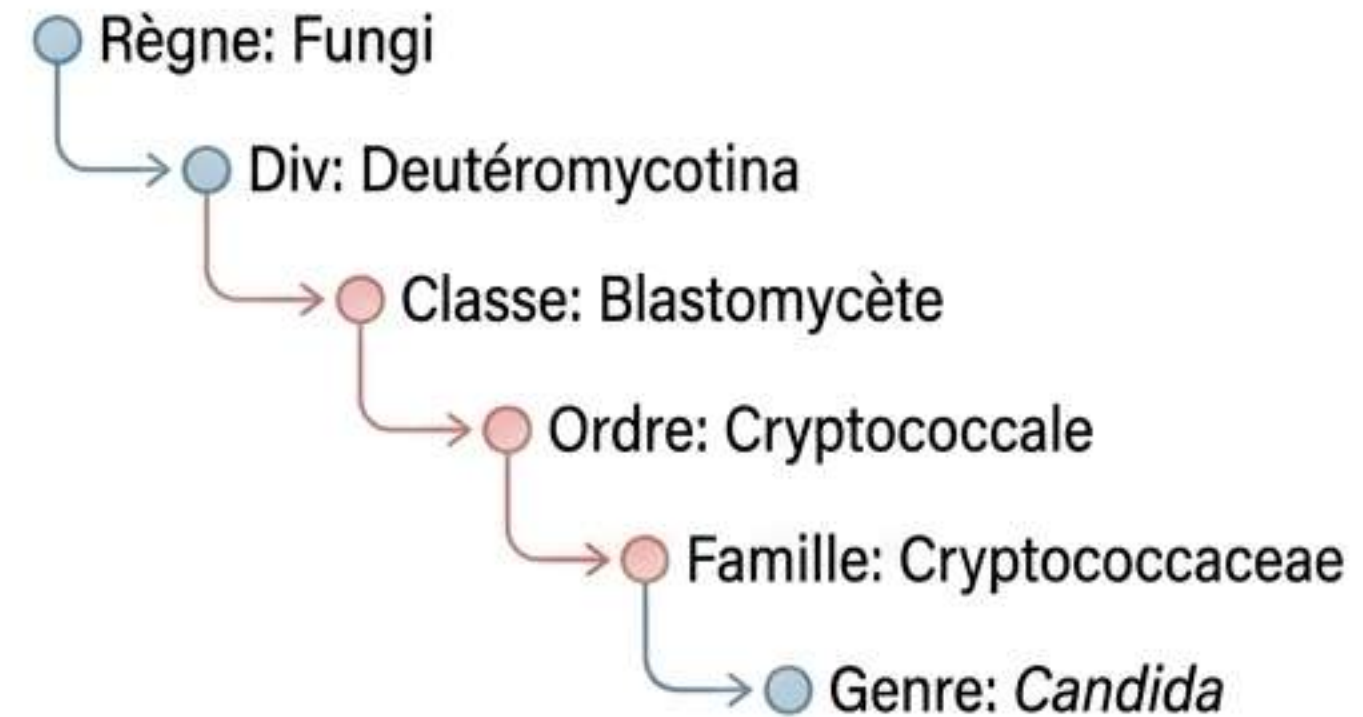
Autres espèces fréquentes : *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*, *C. krusei*. Autres citées : *C. guilliermondii*, *C. dubliniensis*, *C. kefyr*.

2-1-1 Classification Biologique :

Règne : Fungi (champignons) | Division : Deutéromycotina | Classe : Blastomycète | Ordre : Cryptococcale | Famille : Cryptococcaceae [Predicted - Cible QCM de biologie/taxonomie fondamentale].

2-1-2 Habitat Naturel :

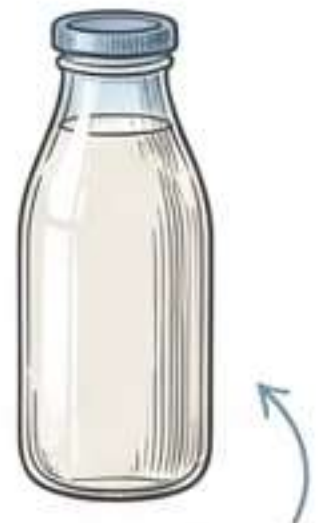
- *C. albicans* : Commensal strict de l'hôte (buccal, digestif, génital).
- Espèces du milieu extérieur (ingestion accidentelle via l'alimentation) :



Eau/Céréales
= *C. tropicalis*



Jus de raisin
= *C. krusei*



Produits laitiers
= *C. kefyr*

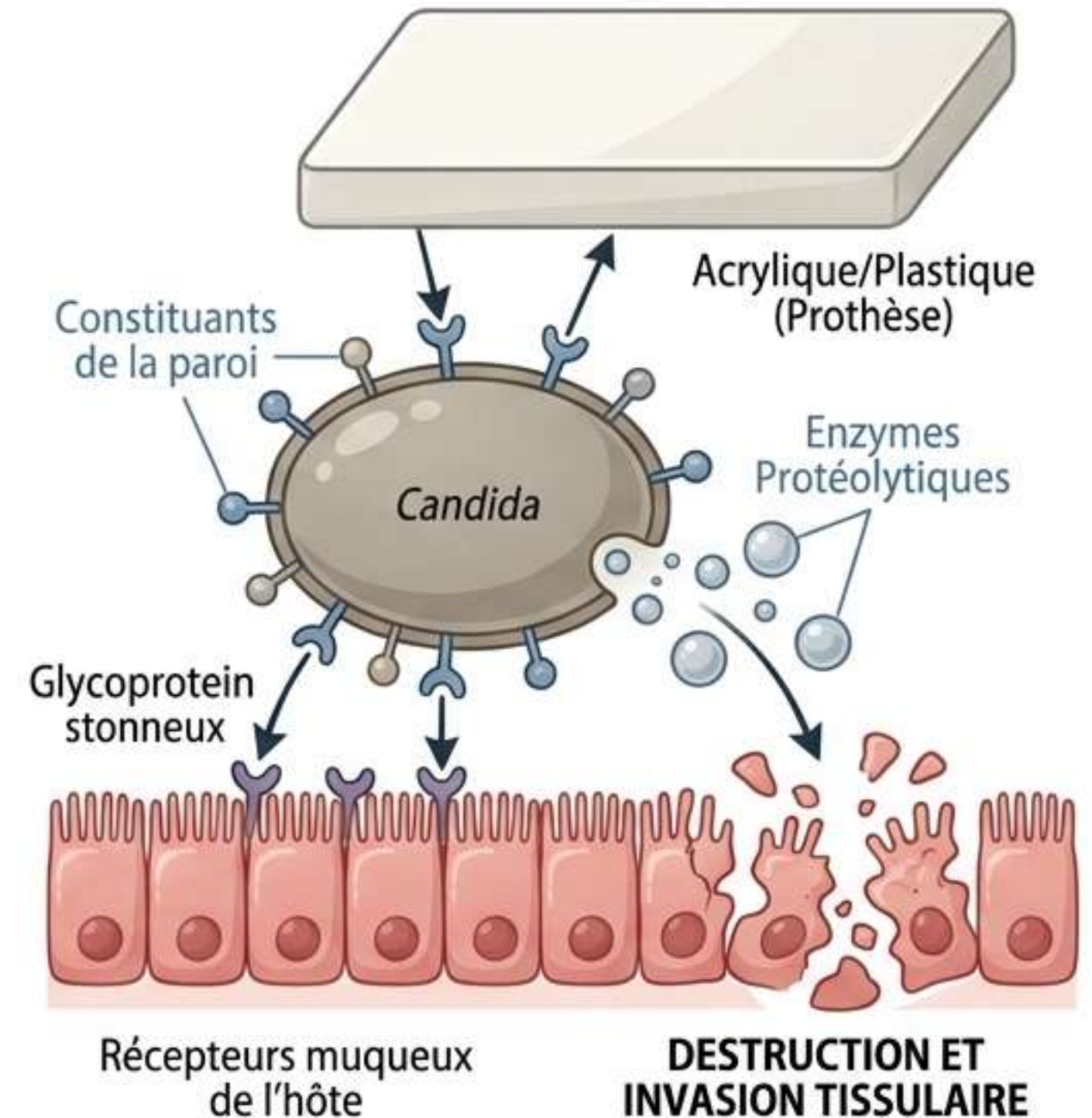
2-2 Pathogénie & 2-3-1 Facteurs Favorisants Intrinsèques

2-2 Pathogénie :

- **Adhérence** : Interaction entre les constituants de la paroi fongique et les récepteurs de l'hôte.
- **Adhésion forte aux surfaces acryliques et plastiques** (expliquant la colonisation des prothèses) [Predicted - Lien fondamental avec la stomatite].
- **Sécrétion** : Sécrétion d'enzymes protéolytiques qui détruisent la muqueuse et favorisent l'invasion.

2-3-1 Facteurs intrinsèques liés à l'hôte : Responsables du passage commensal -> pathogène.

- **Physiologiques** : Âge (prématuré, nouveau-né, nourrisson, sujet âgé avec mauvaise hygiène prothétique), Grossesse (modification hormonale).
- **Liés au Terrain** :
 - Diabète sucré, Immunodépression (SIDA), Tabagisme.
 - Endocrinopathies (Insuffisance surrénalienne, Insuffisance thyroïdienne).
 - **Hyposialie / Xérostomie** : Sécheresse buccale avec absence de sécrétion de salive et diminution des protéines salivaires [Predicted - Condition dentaire critique].
 - Néoplasies (Cancer, leucémie, lymphome).
 - Traumatisme, brûlure, maladies affaiblissant l'immunité générale.



2-3-2 Facteurs Extrinsèques & 3. Introduction à la Clinique

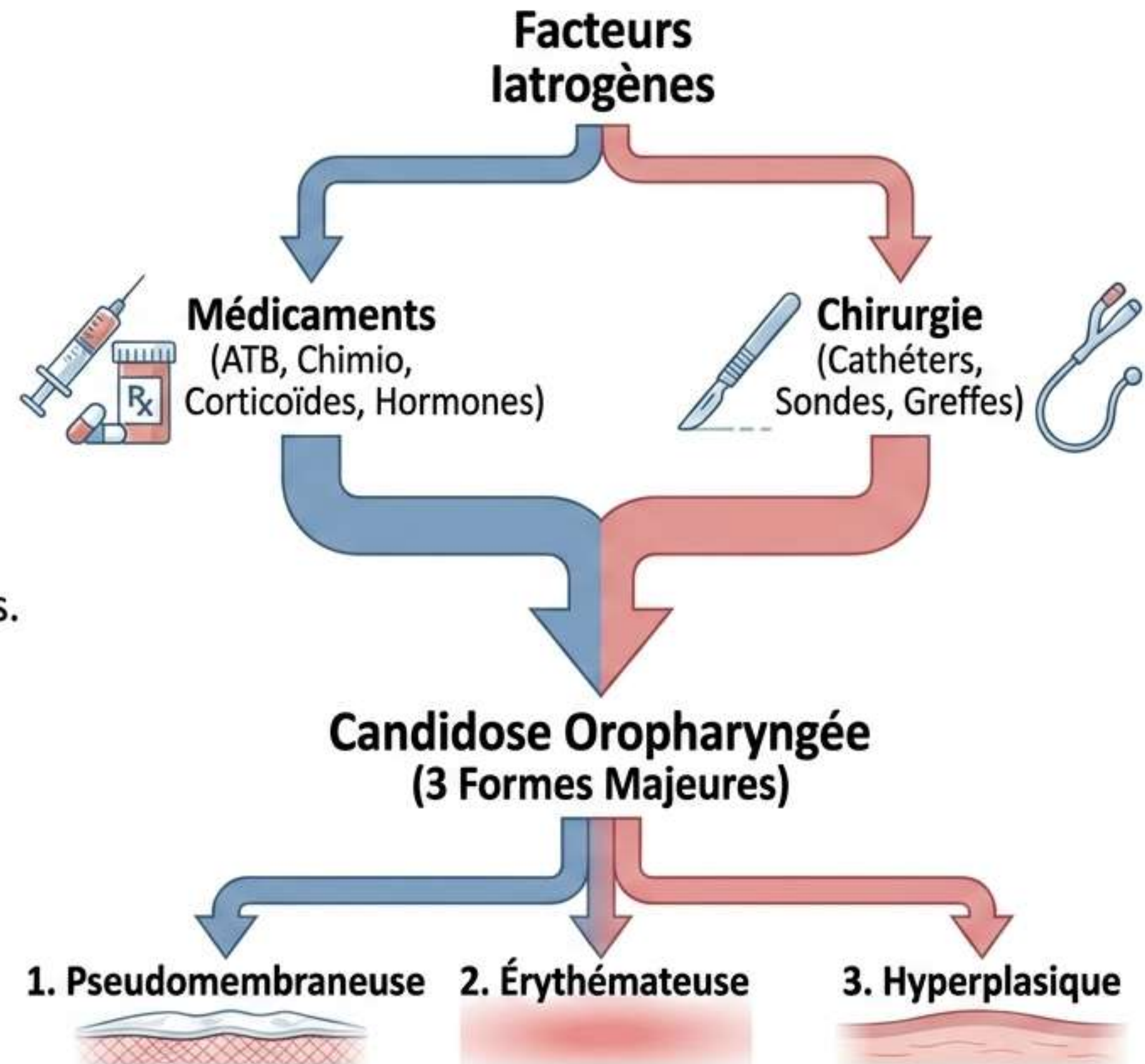
2-3-2 Facteurs extrinsèques et/ou iatrogènes :

- **Traitements médicamenteux :**
 - Antibiothérapie prolongée à large spectre.
 - Hormones contraceptives, Corticostéroïdes.
 - Radiothérapie, chimiothérapie anticancéreuse.
 - Immunosuppresseurs, Antiseptiques.
- **Agressions chirurgicales :**
 - Pose de cathéters intra-vasculaires, sondes, prothèses.
 - Transplantations d'organes.
 - Chirurgie **digestive** et chirurgie cardiaque.

3. Caractéristiques cliniques :

(Dans la candidose généralisée, l'infection buccale n'est qu'un site secondaire).

Les candidoses oropharyngées primitives se divisent en **03 formes cliniques principales** :



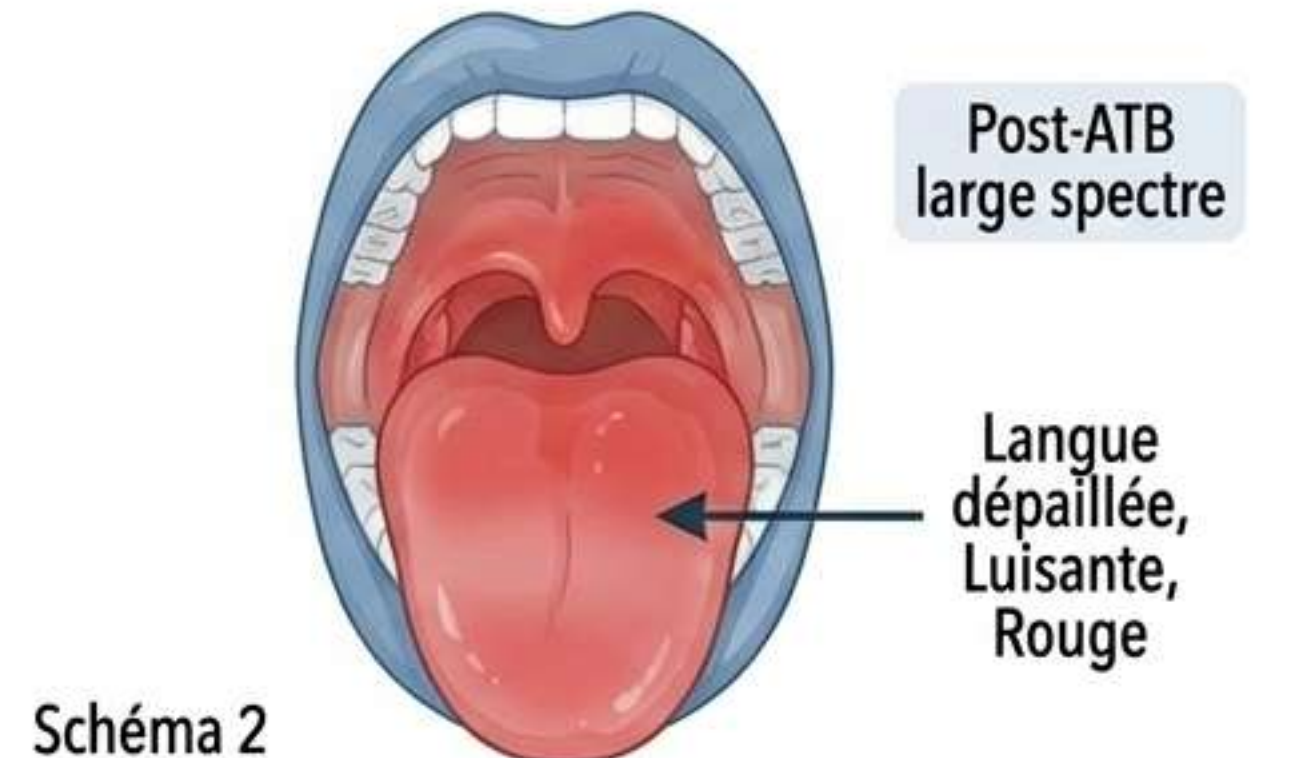
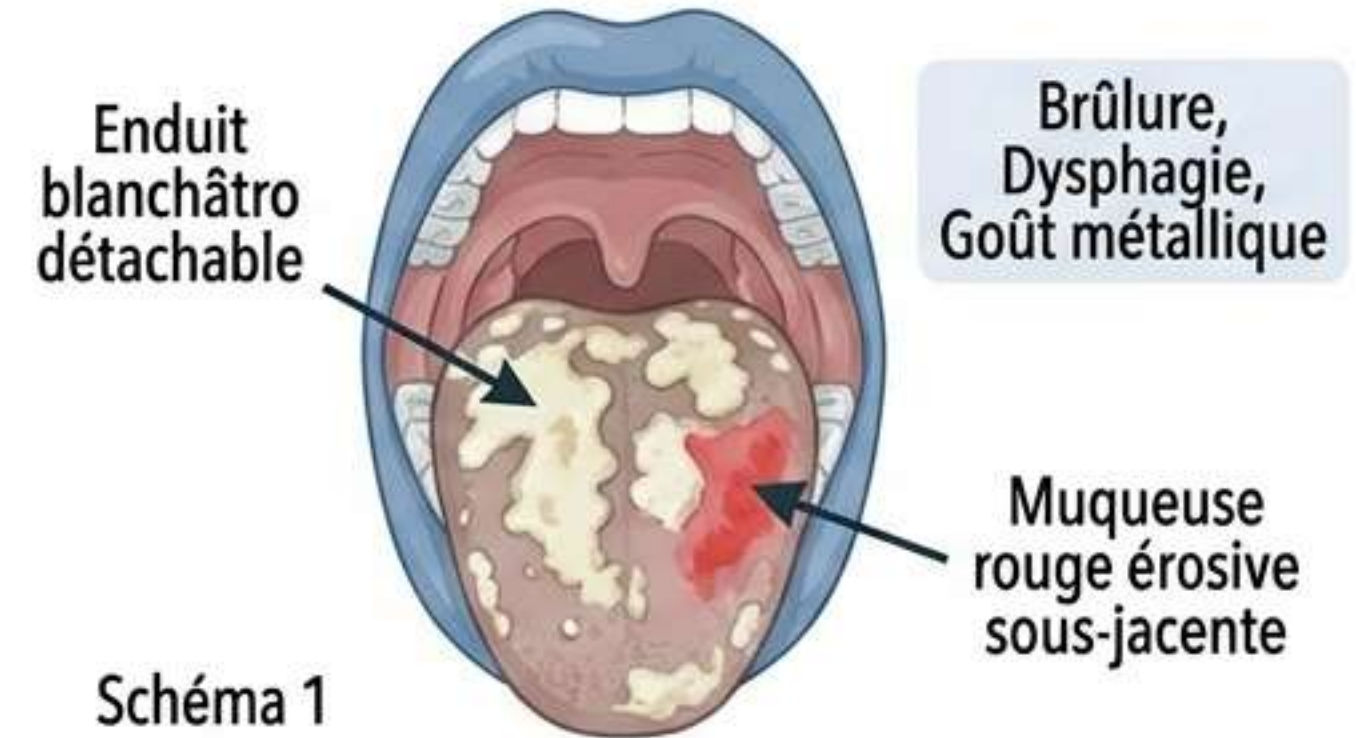
3. Formes Cliniques : Pseudomembraneuse & Érythémateuse

3-1 Candidose pseudomembraneuse (Muguet) :

- **Forme la plus fréquente des candidoses buccales** [Ref: Q2, Q6].
- **Espèce isolée** : *C. albicans*.
- **Terrain** : Nouveaux-nés, prématurés, âgés, radio/chimiothérapie, VIH+/immunodéficiences.
- **Le muguet ± œsophagite peut être révélateur de la séropositivité au VIH** [Predicted – Pathologie sentinelle].
- **Clinique** : Enduit blanchâtre sur muqueuse et langue. Se détache en révélant une muqueuse rouge érosive. Brûlure, dysphagie, goût métallique.
- **Diagnostic différentiel** : White sponge nævus (héréditaire), Lichen plan buccal, Leucoplasie (tabac), Carcinome épidermoïde.

3-2 Candidose érythémateuse atrophique :

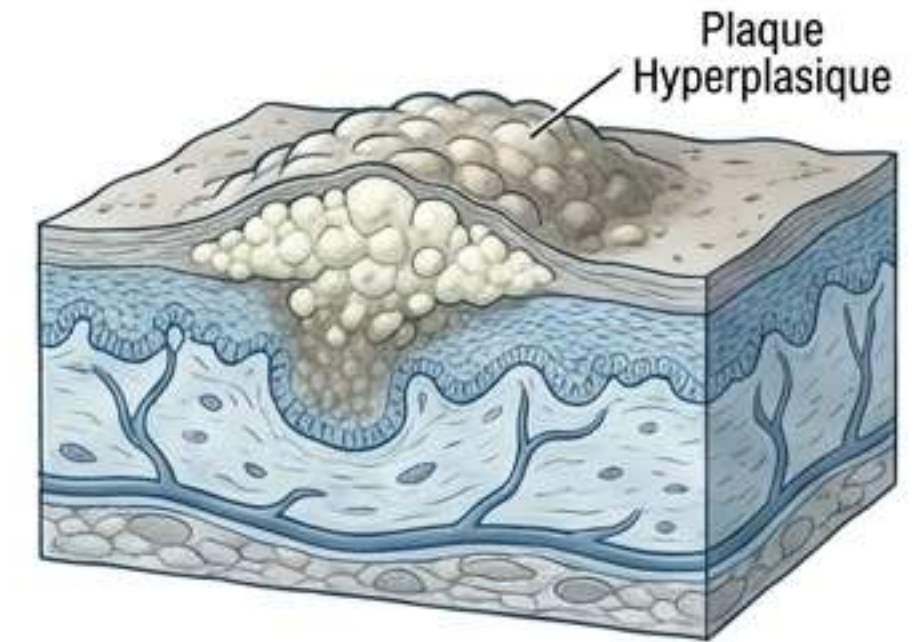
- **Terrain** : Souvent due à la prise d'ATB à large spectre.
- **Clinique** : Touche le palais et le dos de la langue. Muqueuse luisante, rouge, et langue dépaillée. Sensation de brûlure douloureuse lors de l'alimentation.



3. Formes Cliniques : Hyperplasique (CHC) & Stomatite Prothétique

3-3 Candidose hyperplasique chronique (CHC) ou pseudotumorale :

- Moins fréquente. Le tabagisme est le principal facteur de risque associé. Causée par *C. albicans*.
- **Clinique** : Plaques ou nodules blanc-jaunâtre (commissure labiale, muqueuse buccale, palais, langue).
- **Évolution** : Sans traitement, risque de développer une dysplasie et d'évoluer vers un carcinome [Ref: Q6].
- (Régresse si traitée).



Tabagisme → CHC → Sans Traitement → Dysplasie → Carcinome

3-4 Formes chroniques atrophiques ou stomatite prothétique :

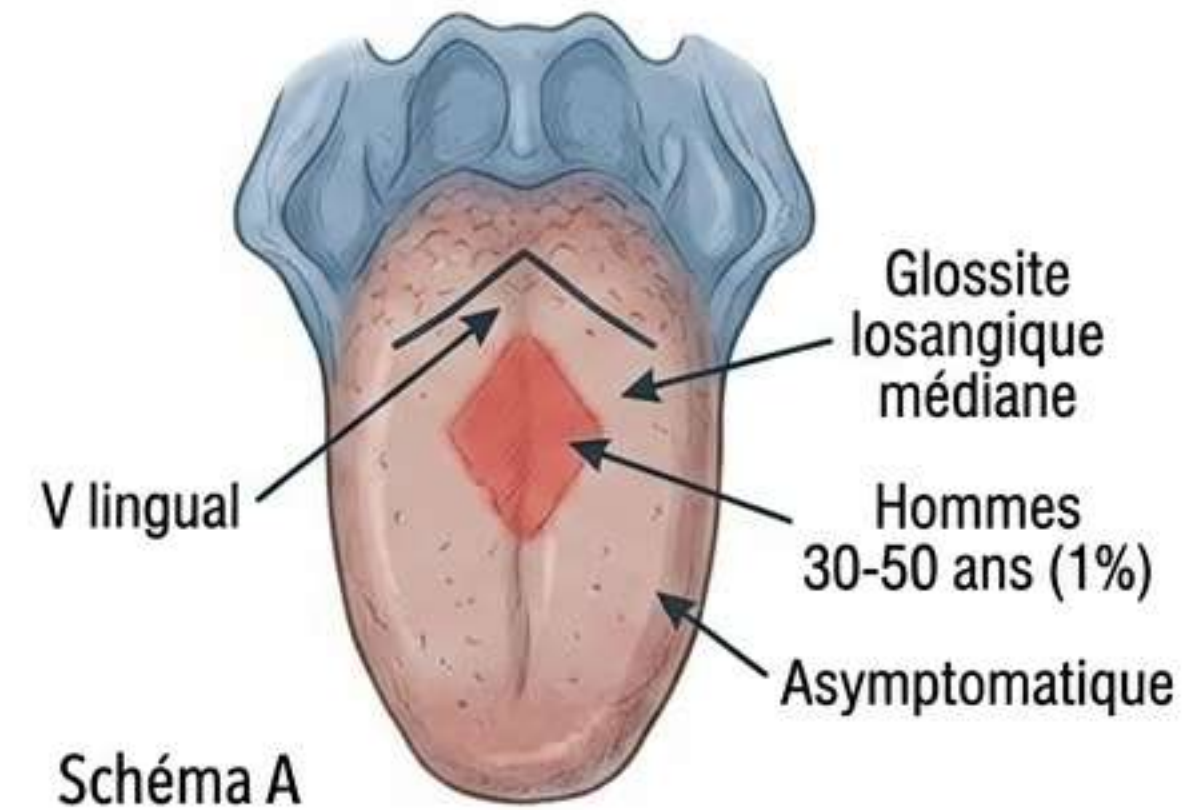
- Apparaît chez les porteurs de prothèses dentaires mobiles.
- **Clinique** : Plaque rouge vif avec atrophie des tissus recouverts par la prothèse.
- **Facilitée par** : Mauvaise hygiène bucco-dentaire, port prolongé, et prothèses mal ajustées [Predicted - Facteurs de risque mécaniques].



3. Formes Localisées : Glossite, Perlèche & Chéilite

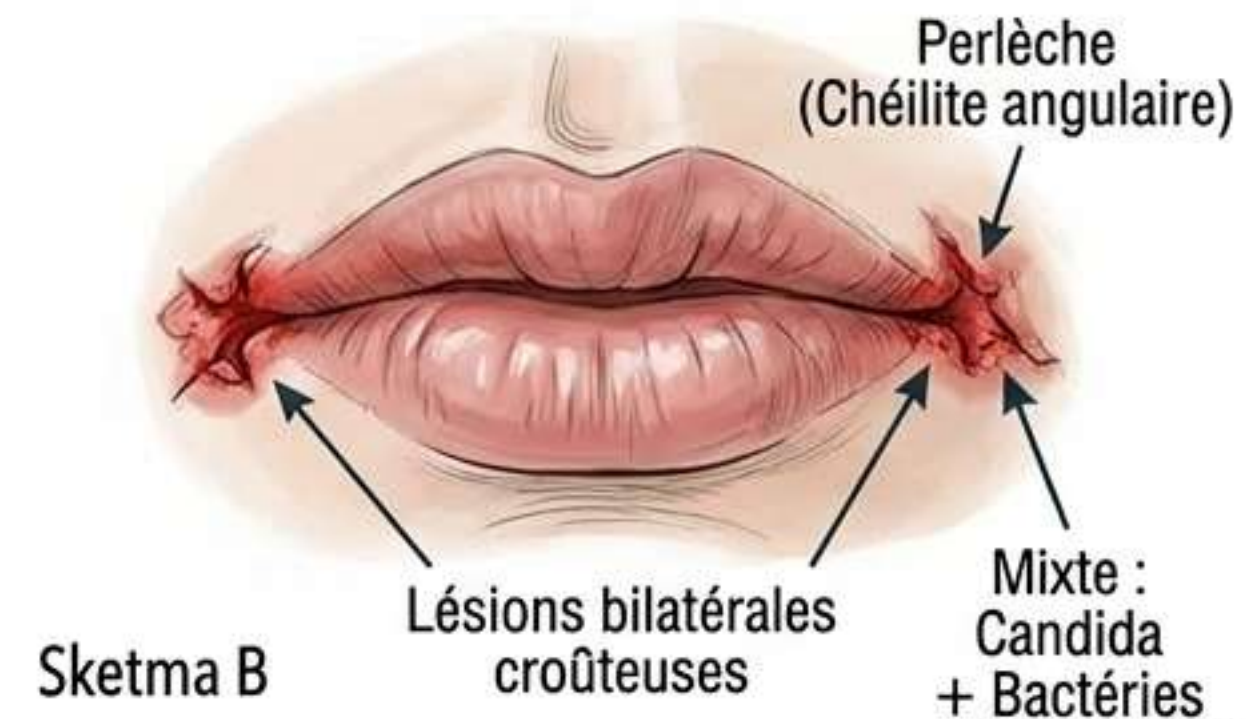
3-5 Glossite losangique médiane (ou rhomboïde médiane) :

- Processus inflammatoire persistant dû à une infection chronique par *C. albicans* (rôle des toxines/enzymes).
- **Clinique** : Plage érythémateuse grossièrement losangique sur le dos de la langue (en avant du V lingual). Lisse, plane ou mamelonnée. Asymptomatique.
- **Épidémiologie** : Présente chez environ 1 % de la population, touche surtout les hommes de 30 à 50 ans [Predicted - Données démographiques ultra-spécifiques].



3-6 Perlèche (Chéilite angulaire) :

- Fissures et lésions croûteuses bilatérales aux commissures labiales. Gêne l'ouverture buccale. Peau rouge, tenace, récidivante.
- **Infection mixte** : Bactérienne (Streptocoques, Staphylocoques) + Fongique (*Candida*) [Predicted - Piège diagnostique plurimicrobien].



3-7 Chéilite candidosique :

- Lésion érythémateuse et érosive des lèvres.

3. Formes Atypiques, VIH et Espèces Non-Albicans

3-8 Langue noire villeuse (Lingua Villosa nigra) :

- Fausse mycose (recherche de *Candida* le plus souvent négative, *Geotrichum* parfois retrouvé sans rôle prouvé). Bénigne, indolore, post-ATB et alcoolo-tabagique.
- Accumulation de kératine sur papilles (aspect velu) + Oxydation par pigments bactériens (teinte noire).

3-9 Érythème gingival linéaire (LGE) :

- Forme la plus courante de maladie parodontale associée au VIH [Ref: Q6] (et autres immunodéprimés).
- Ligne rouge d'inflammation à la jonction gencive-dent (*C. albicans*).

3-10 Candidoses dues aux *Candida non albicans* :

C. glabrata, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *C. dubliniensis*, *C. tropicalis*, *C. kefyr*, *C. guilliermondii*.

- *C. dubliniensis* et *C. glabrata* : Associées au VIH, montrent une sensibilité réduite au fluconazole [Predicted - Phénotype de résistance].
- *C. tropicalis* : L'espèce la plus virulente des non-albicans (cavité buccale, peau, œsophage).



Langue Noire Villeuse
(Fausse Mycose : Kératine + Bactéries)



Érythème Gingival Linéaire
(Marqueur VIH)



dubliniensis / *glabrata* =
**Baisse sensibilité au
Fluconazole**
tropicalis = **Très virulente**

4. Diagnostic : Clinique, Paraclinique et Prélèvements

Le **diagnostic** confronte clinique (majeur), épidémiologie (diabète, SIDA), radiologie et laboratoire.

- Arguments **paracliniques** : Immunodépression marquée par un Taux CD4 < 100 éléments/mm³ et PN < 500 éléments/mm³ [Predicted - Chiffres biologiques à mémoriser].

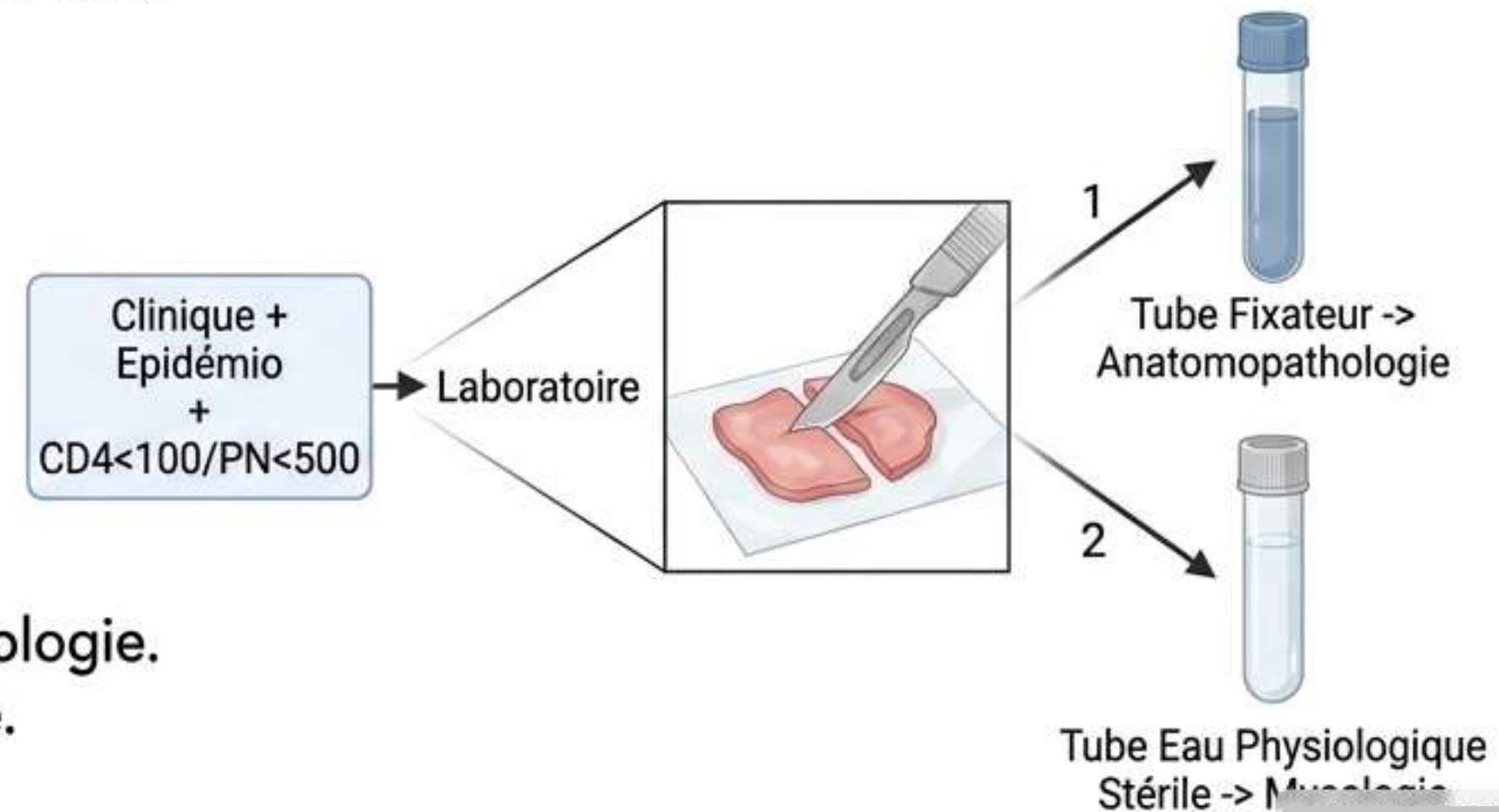
Diagnostic au laboratoire de mycologie (5 étapes) :

1) Prélèvement, 2) Examen direct, 3) Isolement, 4) Identification, 5) Compléments (Sérologie Ac/Ag, Biologie Moléculaire, Spectrométrie de masse MALDI-ToF).

Étape 1 : Le Prélèvement (Règle d'or : Avant toute toilette ou thérapeutique)

- **Exsudats** : Écouvillon stérile.
- **Pus** (abcès à Candida) : Ponction stérile d'abcès non fistulisés (évite contamination bactérienne).
- **Biopsies** (ex: CHC vs Leucoplasie) : La pièce doit être divisée en 2 fragments.

- Fragment **A** : Fixateur histologique -> Anatomopathologie.
- Fragment **B** : Eau physiologique stérile -> Mycologie.



4. Diagnostic au Laboratoire : Direct, Culture et Identification

Étape 2 : Examen direct :

Matériel monté entre lame et lamelle. Évalue le champignon non modifié et sa quantité.

Résultat (Genre *Candida*) : Levures rondes, ovales, bourgeonnantes (2 à 4µ de diamètre) ou pseudomycélium [Ref: Q4].

Étape 3 : Culture (Ensemencement & Isolement) :

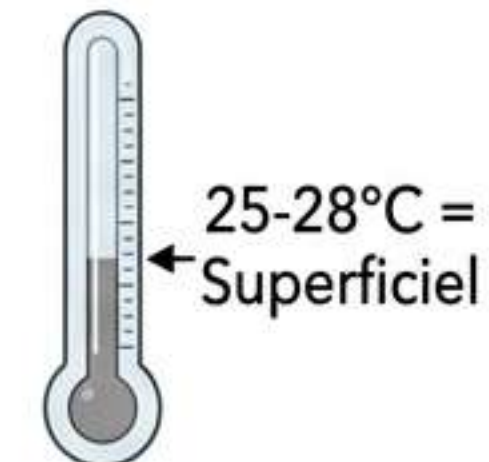
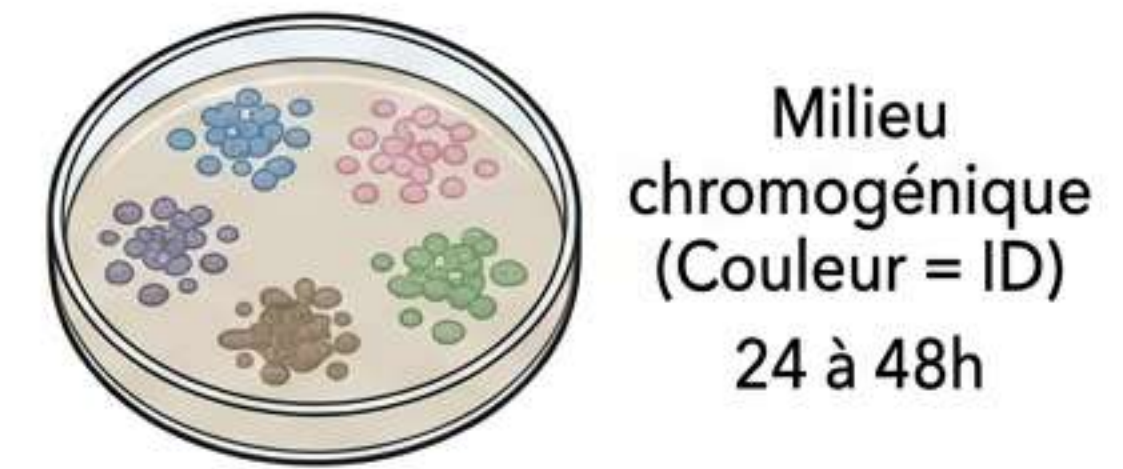
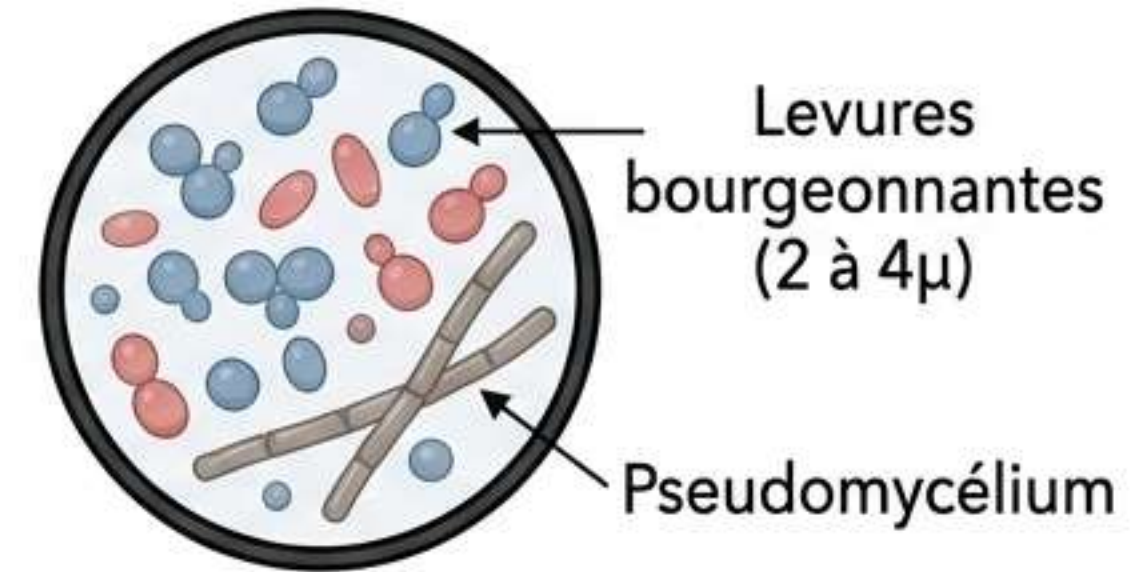
Milieux classiques (Sabouraud, Malt) ou Chromogéniques (isolement + identification + associations simultanées via coloration).

Vitesse : 24h à 48h. Température : 25-28°C (Superficielles), 25-28°C ET 37°C (Profondes).

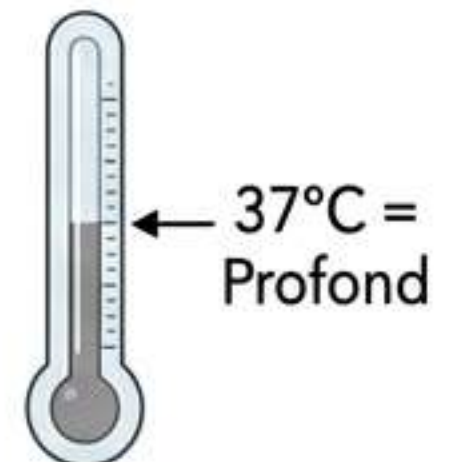
Étape 4 : Identification :

- Critères Macroscopiques : Colonies bombées, lisses, ± blanchâtres.
- Critères Microscopiques : Levures ± pseudomycélium (*Candida* spp).
- Critères Physiologiques : Assimilation des sucres, Tests enzymatiques.
- Critères Morphologiques : Chlamydosporulation, Test de blastèse.

Remarque : Garder un esprit critique face aux résultats (état saprophyte). La quantification des colonies guide le traitement.



Thermomètre 1



Thermomètre 2

5. Traitement : Pronostic et Topiques (1^{ère} Intention)

Pronostic Global : La plupart des candidoses buccales traitées ont un pronostic favorable [Ref: Q6].

Traitement curatif et préventif.

- **Formes légères** : Antifongique topique + hygiène bucco-dentaire.

Début de traitement : Bains de bouche composés (Éludril®, Fungizone®, Eau bicarbonatée à 14 ‰).

Traitement Antifongique Topique (Mycose évidente) :

Nystatine : Antifongique utilisé en 1^{ère} intention pour candidose simple. (Suspension buvable, pastille, rince-bouche 4x/jour pdt 2 sem. Agiter plusieurs minutes puis avaler) [Ref: Q3].

Fluconazole (rinç-bouche), **Miconazole** (gel buccal), **Kétoconazole**. **Fungizone** (topique).

Clotrimazole (pastilles 10 mg voie orale, 5x/jour).

Rappel QCM : Tous ces agents sont des topiques buccaux. La Terbinafine n'est PAS utilisée pour les mycoses buccales [Ref: Q7].

Suivi : Prélèvement de contrôle 1 mois après le début.



Nystatine Suspension
(1^{ère} intention)

Agiter → Garder en
bouche 4x/j (2 sem)
→ Avaler



Miconazole gel



Clotrimazole 10mg
(5x/j)



Non utilisé en buccal

5. Traitement : Voie Systémique (Formes Sévères & Échecs)

Indications : Formes sévères, patients immunodéprimés, échecs répétés des traitements locaux.

Première Ligne Systémique : Fluconazole

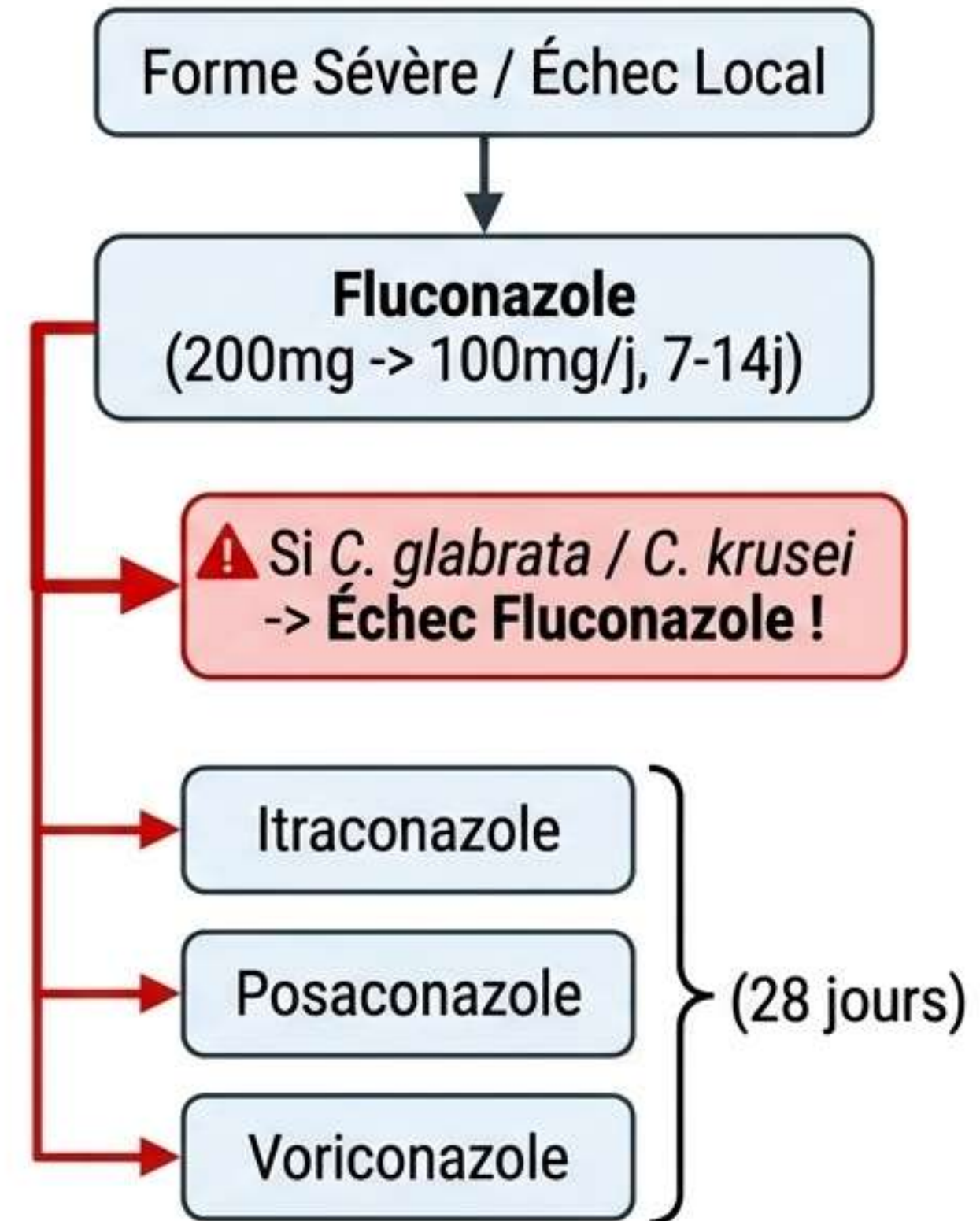
Posologie : Comprimés 200 mg per os 1x/jour, puis 100 mg 1x/jour pendant 7 à 14 jours.

Contre-indication : Inefficace (ou non recommandé) si infection par *C. glabrata* ou *C. krusei* [Predicted - Lien clinique/microbiologie].

Alternatives en cas d'échec au Fluconazole :

- **Itraconazole 200 mg** : Solution buvable 1x/jour (à jeun) pendant 28 jours.
- **Posaconazole 400 mg** : Suspension orale 2x/jour pendant 3 jours, puis 400 mg/jour pour un total de 28 jours.
- **Voriconazole 200 mg** : Voie orale 2x/jour pendant 28 jours.

Approche Holistique : Le traitement médicamenteux doit être accompagné d'une diminution des facteurs prédisposants (Diabète sucré non contrôlé, tabagisme, malnutrition).



Traitements Spécifiques, Prophylaxie et Risques

Candidose Hyperplasique Chronique (CHC) :

- Élimination tabagisme + Topiques (Nystatine/Clotrimazole) + Fluconazole systémique (100-200 mg/j pdt 1-2 sem).
- Chirurgie si non-réponse.
- Les patients doivent être informés du risque de transformation maligne [Predicted - Éthique/Consentement].

Stomatite Prothétique :

- **Hygiène** : Brossage savon doux/liquide vaisselle. Retrait min. 6h/nuit dans l'eau + chlorhexidine (4-5 gouttes). Retirer la prothèse lors des bains de bouche.
- **Médical** : Miconazole topique surface interne (2-4x/j) ou trempage nocturne dans suspension Nystatine.
- Rechutes causées par les biofilms de Candida.

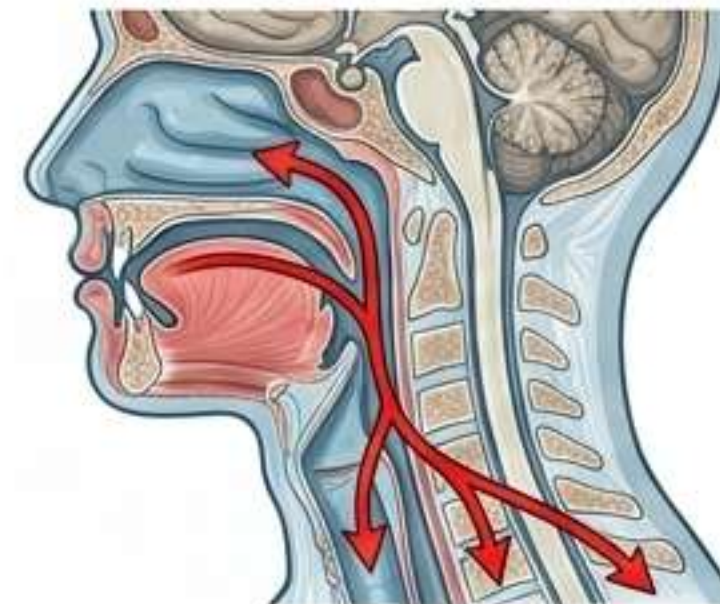
6. Prophylaxie : (VIH, greffés, pathologie maligne). Fluconazole systémique s'est avéré plus efficace que les polyènes topiques.

7. Complications (Mauvais pronostic) :

- Mauvaise observance / hygiène = Rechute.
- Atteinte pharyngée (dysphagie) et dissémination systémique (immunodéprimés) [Predicted - Évolution ultime].



Biofilms = Rechute



Risque : Dysphagie (Pharynx) -> Dissémination Systémique

